

Introduction-généralités :

a. Définition :

C'est le rejet actif par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique.

Les vomissements aigus d'apparition brutale sont à distinguer des vomissements chroniques prolongés ou récidivants car ils relèvent d'étiologies différentes.

b. Intérêts de la question :

- ↳ Motif fréquent de consultation.
- ↳ Diagnostic positif facile : anamnésique.
- ↳ Etiologies multiples : digestives ou extra digestives, aiguës ou chroniques

II. Reconnaître les vomissements :

a. Diagnostic positif :

Le diagnostic positif repose sur l'interrogatoire qui identifie les vomissements comme un rejet actif du contenu gastrique, habituellement précédés de nausées définies par la sensation désagréable de besoin de vomir ou que les vomissements sont imminents.

Ils s'accompagnent souvent d'une hyperactivité du système nerveux autonome : pâleur, sueurs froides, hypotension, bradycardie.

III. Eliminer ce qui n'est pas vomissement :

Les vomissements doivent être différencier de :

1. Régurgitations :

Remontée passive du liquide gastrique dans la bouche sans efforts de vomissements,

2. Mérycisme :

Remontée volontaire, d'aliments récemment digérés dans la bouche où ils sont à nouveau mastiqués, physiologique chez le nourrisson, pathologique chez l'adulte .

IV. Rechercher et traiter une éventuelle complication :

b. Complications hydroélectrolytiques : surviennent surtout lorsque les vomissements sont abondants et répétés

↳ Déshydratation extra-cellulaire :

- Cliniquement : soif, pli cutané, langue sèche et hypotension.

Biologiquement : hyperprotidémie, insuffisance rénale fonctionnelle.

↳ Alcalose métabolique :

- Avec hypokaliémie et hyperchlorémie, élévation du pH sanguin, des bicarbonates, hypocalcémie.
- Peut être responsable de tétanie, d'une asthénie profonde et de troubles du rythme cardiaque.

b. Complications mécaniques :

↳ Syndrome de MALLORY-WEISS :

Déchirure longitudinale et brutale au niveau du cardia provoquée par des efforts de vomissement intense, il se manifeste le plus souvent par des hématomèses de petite abondance.

Le diagnostic est affirmé par l'endoscopie.

Le traitement repose sur les antisécrétoires et les antiémétiques lorsqu'il s'agit d'une hématomèse de petite abondance. Sinon, on aura recours à l'hémostase endoscopique→tamponnement par sonde de BLACKMOORE→chirurgie.

↳ Rupture spontanée de l'œsophage :syndrome de BOERHAAVE

Complication grave, chirurgicale. Elle se manifeste par :

- ✓ Des douleurs thoraciques intenses et brutales.
- ✓ Une insuffisance respiratoire aiguë avec cyanose.
- ✓ Un emphysème sous cutané et médiastinal.
- ✓ Une dysphagie et odynophagie.
- ✓ Une fièvre.

Le diagnostic est évoqué devant la radio du thorax (emphysème médiastinal) et confirmé par le transit aux hydrosolubles qui met en évidence cette rupture.

L'endoscopie est contre indiquée.

Le traitement repose sur la chirurgie + réanimation intensive.

- Avant 24h, le traitement est conservateur (suture de la brèche).
- Au delà de 24h, œsophagectomie ou exclusion œsophagienne s'imposent le plus souvent.

↳ Hématome intra mural de œsophage

Le diagnostic est évoqué des douleurs rétro sternales et une dysphagie récente.

Il est confirmé par l'endoscopie haute.

Le traitement est médical, en cas d'échec→chirurgie.

c. Complications respiratoires :

↳ Pneumopathies d'inhalation :

Syndrome de MENDELSON : lorsqu'il s'agit de vomissements survenant chez un sujet alité et/ou inconscient. Il est prévenu par une aspiration douce du contenu gastrique.

V. Diagnostic étiologique :

Devant la diversité des étiologies, seule une enquête étiologique rigoureuse et stéréotypée permettra d'aboutir à un diagnostic et d'éviter le recours aux investigations inutiles.

Les vomissements aigus sont à distinguer des vomissements chroniques. Ils seront donc envisager séparément.

A. Vomissements aigus :

Enquête étiologique :

Les étiologies des vomissements aigus peuvent être digestives ou extra digestives, bénignes ou graves nécessitant un traitement d'urgence, qu'il soit médical ou chirurgical.

Une enquête étiologique rigoureuse s'impose pour cela, elle reposera sur l'anamnèse et l'examen clinique.

1. Etape clinique :

↳ Caractère des vomissements :

- Mode de début.

- Horaire : post prandiaux (affection digestive), à jeun, matinaux (affection neurologique, grossesse).
- Survenue brutale en jet → HIC ou précédés de nausées.
- Aspect : alimentaire, sanglant (MALLORY WEISS), bilieux, fécaloïde.
- Facteurs déclenchant .
- Evolution.
- Signes associés : signes généraux (AEG, fièvre), digestifs (douleurs abdominales, troubles du transit), extra digestifs (céphalées, vertiges, signes neurologiques).

↳ Terrain :

- Prise médicamenteuse.
- Pathologie digestive ou hépatobiliaire connue.
- Terrain vasculaire : diabète, HTA, dyslipidémie, obésité.
- Notion d'affection endocrinienne ou métabolique (insuffisance surrénalienne, insuffisance rénale, diabète en précisant le type).
- Notion de grossesse ou d'aménorrhée chez la femme.
- Terrain d'éthylisme.

↳ Recherche de signes associés :

- Signes généraux : fièvre, altération de l'état général.
- Signes digestifs : douleurs abdominales, troubles du transit.
- Signes extra digestifs : céphalées, vertiges, signes neurologiques.

↳ Signes d'orientation étiologique :

- Recherche de signes évoquant une urgence chirurgicale : essentiellement par l'examen physique et les investigations :
 - ✓ Occlusion intestinale aiguë : douleurs abdominales, arrêt des matières et des gaz, vomissements parfois fécaloïdes. L'examen clinique retrouve un météorisme.
 - ✓ Péritonite aiguë : antécédent de maladie ulcéreuse, douleurs abdominales diffuses et intenses, fièvre, contracture abdominale.
- Recherche de signes ayant une orientation étiologique : par l'interrogatoire et l'examen physique.

↳ Signes digestifs et hépatobiliaires :

Douleurs abdominales (type et siège) :

- Epigastriques : d'origine gastroduodénale ou pancréatique.
- Hypochondre droit : colique hépatique.

Diarrhée aiguë

Ictère : précédé d'un syndrome pseudo grippal.

↳ Signes neurologiques :

Céphalées, vertiges, bourdonnements d'oreille, signes neurologiques déficitaires, syndrome méningé.

↳ Autres signes :

Douleurs précordiales à irradiation vers le cou, mâchoire, membre supérieur gauche.

Douleurs lombaires à irradiations descendantes vers les organes génitaux externes et les membres inférieurs+ brûlures mictionnelles et hématurie évoquant une colique néphrétique.

2. Etape para clinique :

↳ Devant la suspicion d'une urgence chirurgicale digestive, on réalise un ASP qui montrera :

- # En cas d'OIA des niveaux hydroaériques.
- # En cas de péritonite par perforation d'organe creux : croissant gazeux sous diaphragmatique.

↳ Devant les autres situations, les examens para cliniques seront demandés en fonction des signes d'orientation :

- # Exploration digestive et hépatobiliaire par une échographie abdominale(voire TDM pour meilleure exploration du foie, des voies biliaires et du pancréas), entéroscopie haute, bilan biologique (enzymes pancréatiques, EFH).
- # Exploration cardiaque : ECG, dosage des CPK, LDH.
- # Exploration neurologique : TDM cérébrale, fond d'œil, ponction lombaire avec étude cytbactériologique et biochimique du LCR.

3. Les étiologies :

↳ Parfois le diagnostic est évident :

- **Causes médicamenteuses** : facilement reconnues par l'interrogatoire.
- **La chimiothérapie** : l'incidence des vomissements est fonction de la nature des agents antinéoplasiques , leur dose, l'association de différents agents, leur mode d'administration (la perfusion IV prolongée induit moins de vomissements que la perfusion rapide ou en bolus).
- **Autres** :
 - Radiothérapie.
 - Mal des transport.
 - Intoxication alcoolique aiguë.
 - Intoxication alimentaire, gastro-entérite aiguë.

↳ En l'absence de contexte évident, le diagnostic est orienté par les signes d'accompagnement :

- Les principales causes médicales sont :
 - ✓ IDM : forme postéro-diaphragmatique (ECG+++).
 - ✓ Toxi-infection alimentaire.
 - ✓ Colique hépatique.
 - ✓ Colique néphrétique.
 - ✓ RVA.
 - ✓ Hématome rétro-péritonéal.
 - ✓ Hépatite aiguë médicamenteuse ou virale.
- **Signes neurologiques** :
 - Céphalées et/ou vertiges et/ou signes neurologiques déficitaires.
 - Le diagnostic repose sur l'examen clinique (en particulier neurologique et ORL), le scanner cérébral puis la PL.
 - En présence de céphalées :

- ✓ Syndrome méningé : méningite ou hémorragie méningée.
- ✓ Glaucome aigu.
- ✓ HIC aiguë: hématome sous ou extra dural, tumeur cérébrale, AVC, abcès cérébral à pyogènes ou à toxoplasme.
- ✓ Intoxication au monoxyde de carbone.
- En présence de vertiges, il s'agit souvent d'un syndrome vestibulaire : maladie de MENIERE, syndrome de WALLENBERG...

• **En absence de signes d'accompagnement :**

- ⇒ Le diagnostic repose sur les examens biologiques.
- ⇒ Causes métaboliques :
 - Acidocétose diabétique.
 - Hypercalcémie.
 - Hyponatrémie responsable d'un œdème cérébral.
 - Insuffisance surrénale aiguë.
 - Insuffisance rénale aiguë.
- ⇒ Grossesse méconnue : jeune femme+ vomissements isolés, valeur du dosage de la β HCG.

C. Vomissements chroniques :

Enquête étiologique :

1. Etape clinique :

- ⇒ **Caractères des vomissements.**
- ⇒ **Terrain :**
 - #Prise médicamenteuse.
 - #Pathologie digestive ou hépatobiliaire connue.
 - #Intervention sur le tube digestif.
 - #Pathologie endocrinienne ou affection neurologique ou ORL connue.
 - #Terrain psychologique particulier.
 - #Aménorrhée ou grossesse.

⇒ **Signes d'orientation :**

- **Digestifs** : Clapotage à jeun, pesanteur syndrome occlusif spontanément résolutif, diabète ou affection systémique déjà connue.
- **Extra digestifs** : hypoacousie, céphalées, troubles de la vision, amaigrissement important non expliqué avec signes de carence.

2. Etape para clinique :

- Recherche d'une pathologie digestive ou extra digestive obstructive par FOGD en premier lieu, TOGD, TG, échographie abdominale voire TDM.
- En l'absence d'affection organique obstructive, on procédera à une exploration fonctionnelle dont il faudra préciser le caractère primitif ou secondaire.

3. Les étiologies :

a. Affections digestives : 3 sous groupes :

👉 Sténose antropylorique ou duodénale :

Révélee par des vomissements alimentaires post prandiaux plus ou moins tardifs précédés par une plénitude épigastrique avec clapotage à jeun.

L'examen physique retrouve une voussure épigastrique siège d'ondulations péristaltiques spontanées ou provoquées.

La FOGD elle permettra de faire le diagnostic de la sténose et de préciser sa nature grâce aux biopsies. Les causes sont multiples :

- ✓ Le plus souvent, d'origine ulcéreuse
- ✓ Parfois, il s'agit d'une pathologie néoplasique intrinsèque gastrique ou duodénale (cancer antral ou fundique).
- ✓ Ou de pathologie extrinsèque : néoplasie de voisinage envahissant le duodénum

👉 Sténose chronique de l'intestin grêle :

Le diagnostic est évoqué devant des vomissements bilieux, voire fécaloïdes, notion d'accès occlusifs spontanément résolutifs et itératifs. Parfois ondulations péristaltiques avec météorisme abdominal.

Il sera confirmé par l'ASP (niveaux hydro-aériques du grêle), TG et TDM (entéro scanner) qui retrouvent l'obstacle. L'entéroscopie poussée haute ou basse précisera la nature histologique.

Les principales causes sont :

- Tumorales : lymphome, adénocarcinome, tumeur neuro-endocrine, tumeur surrénale, tumeur bénignes du grêle.
- Inflammatoire : maladie de CROHN ou grêle radique.
- Tuberculeuse.
- Extrinsèque : carcinose péritonéale, brides post opératoires.

👉 Troubles de la motricité gastro-intestinale :

• Gastroparésie :

L'atteinte de l'innervation intrinsèque de l'estomac est à l'origine d'une stase gastrique qui entraîne à son tour des vomissements.

La FOGD évoquera le diagnostic en montrant la stase alimentaire avec absence d'individualisation d'une sténose digestive.

Le diabète est de loin l'étiologie la plus fréquente (DID+++), plus rarement il s'agit d'une amylose digestive, sclérodermie, lupus érythémateux disséminé.

• Pseudo obstruction intestinale chronique :

Réalise un tableau clinique de sub occlusion à répétition avec épisodes de rémission de durée variable, leur répétition aboutit à un état de dénutrition.

L'ASP montre des niveaux hydroaériques, les patients ont alors fréquemment des laparotomies blanches.

Le diagnostic reposera sur un faisceau d'argument cliniques, morphologiques et surtout manométriques (manométrie du grêle montrera des anomalies des CMM).

Les causes des pseudo obstructions sont nombreuses :

❖ Causes secondaires :

✓ Endocriniennes ou métaboliques : hypothyroïdie, hyperparathyroïdie, phéochromocytome, diabète.

✓ Neurologiques : maladie de PARKINSON

✓ Musculaire.

❖ POI primitive.

b. Affections neurologiques :

✕ HIC.

✕ Migraine.

✕ Syndrome vestibulaire.

c. Affections psychogènes :

C'est un diagnostic d'exclusion et ne peut être retenu qu'après avoir éliminer les affections organiques. On en distingue deux principales affections :

Anorexie mentale : les vomissements sont souvent dissimulés.

✓ L'hystérie ou la simulation : dans ce cas, les vomissements sont souvent spectaculaires.

VI. Cas particulier de la grossesse :

✚ Des vomissements sont fréquents en début de grossesse et sont considérés comme physiologiques lorsqu'ils n'entraînent pas d'altération de l'état général ni d'anomalies biologiques. En revanche, des vomissements ou des nausées doivent être considérés comme pathologiques lorsqu'ils débutent après le premier trimestre ou en cas d'anomalies biologiques associées

✚ **HYPEREMESIS GRAVIDARUM** correspond aux vomissements gravidiques incoercibles du premier trimestre. Ces vomissements entraînent un amaigrissement et des troubles électrolytiques qui motivent le plus souvent une hospitalisation. La cause exacte de cette affection n'est pas connue et l'origine semble multifactorielle. On observe fréquemment au cours de cette affection des anomalies des tests hépatiques avec parfois une hypertransaminasémie importante et éventuellement un ictère ce dernier disparaît après la correction des troubles hydroélectrolytiques et l'arrêt des vomissements. Il peut récidiver lors d'une grossesse ultérieure avec hyperemesis gravidarum. Des cas d'encéphalopathie de GAYET-WERNICKE secondaires à une carence en vitamine B1 ont été observés. Le traitement de l'hyperemesis gravidarum comporte habituellement l'isolement, la correction des désordres hydroélectrolytiques, la nutrition parentérale comportant un apport de vitamine B1 et éventuellement un traitement antiémétique par voie intraveineuse. L'efficacité de la méthylprednisolone a été montrée dans une étude.

✚ Au cours du troisième trimestre, les vomissements sont toujours pathologiques, il faudra rechercher leurs causes pour éventuellement les traiter.

a. La stéatose hépatique aiguë gravidique :

Pathologie rare mais potentiellement mortelle, elle se manifeste par des nausées et vomissements, des douleurs abdominales en particulier épigastriques, une polyurie et une polydipsie. L'ictère peut se voir. Une HTA ou une protéinurie sont fréquentes. En l'absence de traitement, on peut avoir une évolution vers l'encéphalopathie hépatique.

On peut avoir des anomalies biologiques à type d'hyperbilirubinémie, TP et facteur V et fibrinogène diminués dans les formes sévères. Une hypoglycémie peut également se voir. Une thrombopénie, qui peut révéler l'affection, est fréquente, associée ou non à d'autres signes de coagulopathie de consommation. Une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et une hyperuricémie sont également fréquentes.

L'échographie retrouve inconstamment un foie hyperéchogène.

Le traitement repose sur l'évacuation utérine précoce qui reste le principal traitement de la SHAG.

b. La pré éclampsie :

les deux principaux signes sont l'hypertension artérielle et la protéinurie. La prééclampsie. Elle est plus fréquente chez les nullipares et ne récidive donc pas systématiquement lors des grossesses ultérieures.

Le traitement repose sur le traitement médical de la prééclampsie associé le plus souvent à l'évacuation utérine.

VII. Traitement :

1. Traitement des complications :

- ✓ Correction des troubles hydroélectrolytiques par pose d'une ou de plusieurs voies veineuses.
- ✓ Le collapsus doit être traité immédiatement par des gélamines type : Plasmagel®, plasmine®.
- ✓ La déshydratation est corrigée par des solutés salés isotoniques. L'hypokaliémie et l'alcalose sont corrigés par le chlorure de potassium en perfusion.

2. Traitement étiologique : si possible

3. Traitement symptomatique des vomissements : antiémétiques

trois classes de médicaments:

Médicaments à action centrale pure:

- ✓ Antihistaminiques H1: diphenhydramine, alizapride, métopimazine.

Médicaments à action centrale et périphérique:

- ✓ Antidopaminergiques: metoclopramide, dompéridone
- ✓ Inhibiteurs des récepteurs 5-HT₃ de la sérotonine: sétrons (ondansétron, granisétron)

Médicaments à action périphérique pure:

- ✓ -Cholinergiques spécifiques: cisapride.

✓ -Agoniste de la motiline: érythromycine

Tableau 6. – Principaux médicaments antiémétiques

Action	DCI	Nom commercial®	Formes
Action centrale			
Antihistaminique H ₁	Diphénhydramine	Nautamine Dramamine	p.o. p.o.
Phénothiazines	Alizapride	Plitican	p.o. i.m. i.v.
	Métopimazine	Vogalène	p.o. i.m. i.v.
	Chlorpromazine	Largactil	p.o. i.m. i.v.
Butyrophénones	Halopéridol	Haldol	p.o. i.m. i.v.
	Dropéridol	Droleptan	i.m. i.v.
Action centrale et périphérique			
Antidopaminergique	Métoclopramide	Primpéran	p.o. i.m. i.v.
		Anausin	p.o.
	Dom Périgone	Motilium	p.o.
		Péridys	p.o.
Antisérotoninergique	Ondansétron	Zophren	p.o. i.v.
	Granisétron	Kytril	p.o. i.v.
	Tropisétron	Navoban	p.o. i.v.
Action périphérique			
Cholinergique spécifique	Cisapride	Prepulsid	p.o.
Agoniste de la motiline	Érythromycine	Érythrocline	p.o.

Conclusion :

- ✗ Les vomissements constituent un symptôme fréquent de consultation en gastro-entérologie.
- ✗ Il convient de rechercher leurs complications qui peuvent être dramatiques et de les traiter.
- ✗ Il est important de distinguer entre vomissement aigus et chroniques, vu qu'ils posent des problèmes différents de prise en charge urgente, de diagnostic étiologique.
- ✗ Ils relèvent parfois de pathologies bénignes mais peuvent cacher une pathologie plus grave qu'elle soit de traitement médical ou chirurgical.
- ✗ Il est important chez la femme enceinte de chercher une pathologie sous-jacente et de ne pas les rattacher systématiquement à la grossesse.
- ✗ Le traitement repose sur le traitement des complications, traitement de l'étiologie et d'un traitement symptomatique.